Algoritmo CIF — Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Lumbar. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. c3105ed6

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿El dolor CENTRALIZA con movimientos repetidos (Método McKenzie/MDT)?

- SÍ → 3 Dolor Radicular Lumbar
- NO → 3 Dolor Radicular Lumbar

1c ¿Hay déficit de fuerza, sensibilidad o reflejos en la pierna (comparado con el lado sano)?

- SÍ → 5 Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)
- NO → sin hipótesis

SÍ

1 ¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda?

NO

2 ¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante?

1 ¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda?

- **SÍ** — SLR positivo <60° o Test de Slump positivo → → desvío 1b
- **NO** — Sin irradiación predominante a la pierna → sin hipótesis

2 ¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante?

- **SÍ** — Dolor bilateral en glúteos/muslos, alivio con "signo del carrito de compras" → 4 Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica
- **NO** — Sin este patrón → sin hipótesis
- **VASCULAR** — Los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie, sin sentarse ni flexionar: sospecha de claudicación vascular → derivación médica → **Derivación médica**: Sospecha de claudicación vascular (los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie): derivación médica para valorar la circulación de las piernas.

Todas → sigue en el paso 3 ↓

↓ Paso 3: viene del paso 2

3 ¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante?

todas

4 ¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.)

3 ¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante?

- **Agudo/Rigidez** — Síntomas <16 días, sin dolor bajo la rodilla y restricción segmentaria hipomóvil → 1 Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)
- **Persistente/Inestabilidad** — Dolor en rangos finales o posturas sostenidas con sensación de "fallo" → 2 Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)
- **Ninguno de los dos** — Continuar con el patrón de dolor inespecífico → sin hipótesis

4 ¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.)

- **DISCOGÉNICO** — Dolor en línea media + preferencia direccional o centralización con movimientos repetidos; puede cambiar de lado → 6 Dolor Lumbar Discogénico
- **FACETARIO** — Paramedial unilateral, dolor en extensión o extensión + rotación, sin pasar de la rodilla; los repetidos no alivian → 7 Dolor Lumbar Facetario
- **SACROILÍACA** — Dolor en zona de Fortin sin dolor en Tuber, no centraliza → 8 Dolor de la Articulación Sacroilíaca
- **MIOFASCIAL** — Banda tensa palpable + punto hipersensible + el paciente reconoce el dolor provocado → 9 Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar
- **NINGUNO** — Sin patrón predominante → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor lumbar inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0